PROTOCOLLO 89

Esposizione graduale al movimento mandibolare

Ridurre la paura e l'evitamento di masticazione e apertura

FASE	QUADRO CLINICO	DURATA	FREQUENZA
Subacuta e cronica	Kinesiofobia, evitamento	20 a 30 minuti	1 o 2 sedute a settimana

Indicazioni

- ✓ Evitamento di cibi o attività
- ✓ Paura del movimento mandibolare
- ✓ Dolore persistente

Controindicazioni e precauzioni

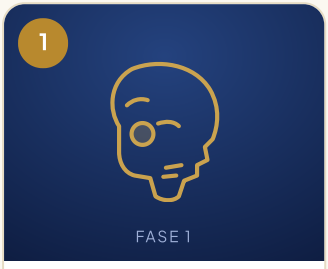
- ! Red flags non escluse dal medico
- ! Peggioramento rapido e non spiegato dei sintomi
- ! Condizioni sistemiche non controllate
- ! Assenza di consenso informato del paziente

Posizionamento

Paziente: seduto o supino secondo la fase.

Fisioterapista: di fronte al paziente.

Esecuzione passo dopo passo



Gerarchia
Elenca con il paziente le attività temute, dalla più facile alla più difficile.



Primo passo
Inizia dall'attività meno temuta.



Ripetizione
Ripeti finché l'ansia si riduce.



Progressione
Passa all'attività successiva.

Dosaggio

PARAMETRO	INDICAZIONE
Gerarchia	5 a 10 attività
Frequenza	esposizione quotidiana
Revisione	ogni seduta

Criteri di rivalutazione

LIMITAZIONE FUNZIONALE	DOLORE (NRS)	ADERENZA
____ / 10	____ / 10	____ %
masticare, parlare, sbadigliare	peggiore della settimana	esercizi svolti a casa

Punti chiave

- ✓ Il paziente sceglie il ritmo
- ✓ Celebra i progressi
- ✓ Collega alle attività significative

Errori da evitare

- ! Saltare i passi
- ! Esporre senza preparazione
- ! Ignorare la paura

Esercizio domiciliare associato

ESERCIZIO	ESECUZIONE	DOSAGGIO
Esposizione quotidiana	Eseguire l'attività del livello raggiunto	ogni giorno

! **Nota clinica.** Esempio di gerarchia: pane morbido, mela a fette, panino, mela intera.

Bibliografia essenziale

1. Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: report of a work in progress. J Oral Rehabil. 2018;45(11):837–844.
2. Michiels S. et al. Diagnostic criteria for somatosensory tinnitus: a Delphi process and face-to-face meeting to establish consensus. Trends Hear. 2018;22:2331216518796403.